

L'hématurie microscopique désigne la présence d'une **petite quantité de sang dans les urines, visible seulement au microscope** — pas à l'œil nu. Le terme « asymptomatique » signifie qu'elle a été découverte lors d'un examen alors que vous vous sentiez bien. La plupart des causes sont bénignes, mais comme il peut parfois s'agir d'un signe précoce d'un problème important, un bilan s'impose.

Ce que cela signifie

Un examen des urines peut détecter des globules rouges bien trop peu nombreux pour colorer les urines. Leur présence est fréquente et, à elle seule, ne constitue pas un diagnostic — c'est un **signal qui mérite un examen complémentaire**. Votre équipe commencera généralement par confirmer leur présence grâce à un examen urinaire adapté (une bandelette réactive seule ne suffit pas).

Causes

Il existe de nombreuses causes possibles, la plupart bénignes :

- **Causes courantes et bénignes** : exercice intense, infection récente, menstruations ou activité sexuelle récente
- **Causes traitables** : un calcul urinaire, une hypertrophie de la prostate ou une affection rénale
- **Plus rarement**, c'est le premier signe d'une tumeur de la vessie ou du rein — d'où l'intérêt du bilan

Souvent, aucune cause précise n'est retrouvée, ce qui est rassurant.

COMPRENDRE LES TERMES

Hématurie

Présence de sang dans les urines.

Microscopique

Visible seulement au microscope, pas à l'œil nu.

Asymptomatique

Découverte sans aucun symptôme.

Analyse d'urine

Examen qui confirme et quantifie le sang.

Cystoscopie

Examen de l'intérieur de la vessie à l'aide d'une fine caméra.

Uroscanner

Scanner détaillé des reins et des voies urinaires.

Bilan fondé sur le risque

L'étendue des examens dépend de votre risque personnel.

DOIS-JE M'INQUIÉTER ? En général non — la plupart des cas ont une cause bénigne ou pas de cause identifiable. Le bilan est une précaution raisonnable, pas le signe que votre équipe s'attend à un problème sérieux. Les examens sont adaptés à votre risque personnel : tout le monde n'a pas besoin de tous les tests.

Comment on le diagnostique

Votre équipe évalue votre **risque** — notamment votre âge, le tabagisme (facteur de risque majeur) et la quantité de sang détectée — puis propose un bilan adapté :

- 1 **Confirmer** la présence du sang et revoir vos antécédents et éventuels symptômes.
- 2 **Imagerie** des reins et des voies urinaires — une **échographie** ou un **uroscanner**.
- 3 Une **cystoscopie** — un examen rapide de l'intérieur de la vessie — pour les patients à risque plus élevé.
- 4 Analyses sanguines/urinaires si une cause **rénale** est suspectée.

La suite

- Si une cause est trouvée, votre équipe la **traite**.
- Si rien n'est retrouvé, un simple **suivi par analyses d'urine** peut être proposé.

Bon à savoir

- **Arrêter de fumer** est la meilleure chose que vous puissiez faire pour la santé de vos voies urinaires.
- Signalez à votre équipe si vous prenez un **anticoagulant** — cela ne dispense pas du bilan.
- Mentionnez un exercice intense récent, des menstruations ou une infection récente, qui peuvent expliquer le résultat.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Du **sang visible** dans les urines (rose, rouge ou couleur thé), avec ou sans caillots
- Une douleur dans le flanc ou le bas-ventre, ou une brûlure en urinant
- De la fièvre ou des difficultés à uriner

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'hématurie microscopique, c'est une infime quantité de sang détectée à l'analyse d'urine — la plupart des causes sont bénignes, mais un bilan vaut la peine.
2. Les examens sont adaptés à votre risque personnel et peuvent inclure une imagerie et un examen de la vessie ; tout le monde n'a pas besoin de tous les tests.
3. Ne négligez pas le bilan, surtout si vous fumez. Appelez immédiatement si vous voyez du **sang visible** dans les urines.